

EMERGENCY OPERATIONS CENTER — PERIODE 20 AUGUST 2026

LAPORAN INFOGRAFIS EOC KEMENKES RI:
EKSEKUTIF KRISIS KESEHATAN KEBENCANAAN

Analisis Situasi Kebencanaan, Dampak Korban, dan Mobilisasi Kesiapsiagaan Darurat

PERIODE PEMANTAUAN
20 August 2026 (24 Jam)CAKUPAN
38 ProvinsiPEMBARUAN TERAKHIR
21 August 2026, 05:00 WIBDITERBITKAN OLEH
Pusat Krisis Kesehatan

ENAM INDIKATOR UTAMA KRISIS KESEHATAN NASIONAL

3

TOTAL KEJADIAN BENCANA

Kejadian tercatat, seluruh Indonesia

0

KORBAN MENINGGAL DUNIA

jiwa

0

KORBAN LUKA (BERAT & RINGAN)

jiwa

0

KORBAN HILANG

jiwa, dalam pencarian aktif

0

PENGUNGS DI POSKO

jiwa, tersebar di posko

44

PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS

jiwa, akumulasi nasional

RINGKASAN EKSEKUTIF ANALISIS SITUASI (24 JAM)

Sepanjang periode pemantauan 24 jam pada tanggal 20 August 2026, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI mencatat akumulasi **3 kejadian bencana** yang terdistribusi secara spesifik pada dua provinsi target. Rincian insiden mencakup **Kebakaran Hutan dan Lahan: 2 Kejadian (Wilayah: KALIMANTAN TENGAH); Kebakaran: 1 Kejadian (Wilayah: KALIMANTAN TIMUR)**. Evaluasi dampak epidemiologis menunjukkan tingkat fatalitas nol dengan **0 jiwa meninggal dunia** (Case Fatality Rate/CFR: 0%), penanganan medis langsung terhadap **0 jiwa korban luka-luka** (Injury Rate: 0/insiden), serta penelusuran aktif terhadap **0 jiwa korban hilang**. Namun demikian, dampak paparan lingkungan dan kerugian materiil secara langsung memapar akumulasi **44 jiwa penduduk terdampak** di wilayah pemukiman terisolasi.

Dalam aspek penanganan pengungsian dan kerentanan kesehatan lingkungan, tercatat sebanyak **0 jiwa pengungsi** yang menetap di posko darurat, sehingga Rasio Pengungsian berada pada angka 0%. Guna mengantisipasi eskalasi skenario terburuk, Klaster Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berkordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta BPBD setempat dalam menyiapkan cadangan logistik darurat. Fokus perhatian diarahkan pada pencegahan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular berbasis lingkungan—khususnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan partikulat asap karhutla dan Penyakit Diare—melalui penyediaan paket sanitasi air bersih, pembagian masker respirator/bedah, dan pemantauan kualitas udara sesuai standar Panduan Klaster Kesehatan WHO dan IHR 2005.

Sebagai bentuk komando taktis dan respon cepat, EOC Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI menginstruksikan aktivasi Siaga Darurat pada jejaring pelayanan kesehatan terdampak. Langkah-langkah kunci mencakup penyiapan cadangan Tim Medis Darurat (Emergency Medical Team / EMT Tipe 1) di tingkat kabupaten, optimalisasi sistem rujukan darurat SPGDT 119, dan pengkondisian 19 RS Siaga serta 49 Puskesmas Siaga di dalam radius terdampak. Integrasi data meteorologi BMKG dimanfaatkan secara real-time untuk memprediksi arah sebaran polutan asap dan potensi titik panas (hotspot) susulan, sementara koordinasi penanggulangan bencana terpadu dilaksanakan bersama BNPB, Basarnas, dan unsur TNI/Polri guna menjamin ketersediaan jalur evakuasi medis terpadu bilamana terjadi peningkatan status darurat.

Status Komando & Arahan: INSTRUKSI KOMANDO EOC KEMENKES RI: Pertahankan status SIAGA DARURAT di seluruh Dinkes terdampak. Aktifkan pemantauan SKDR 24/7 untuk potensi kasus ISPA, siagakan buffer stock logistik masker dan obat-obatan emergensi, serta pastikan kesiapan rujukan darurat SPGDT di RS rujukan regional.

PETA SPASIAL SEBARAN BENCANA & ANOTASI WILAYAH TERDAMPAK

PETA SEBARAN SPASIAL KEJADIAN BENCANA & TITIK PIN MARKER LOKASI TERDAMPAK



Sintesis Spasial Sebaran Bencana: Pemetaan spasial krisis kesehatan per 20 August 2026 mengidentifikasi konsentrasi ancaman di Pulau Kalimantan, yang terbagi dalam dua klaster risiko utama: klaster kebakaran pemukiman/perkotaan di Kota Balikpapan (Kalimantan Timur) serta klaster kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Selatan dan Kapuas (Kalimantan Tengah). Visualisasi peta menunjukkan koridor paparan asap karhutla yang berpotensi meluas secara lintas batas kabupaten akibat dinamika angin darat. Meskipun faskes setempat tidak mengalami kerusakan fisik, radius siaga 25 km mencakup jalur rujukan utama yang menghubungkan titik kejadian dengan jejaring RS rujukan regional.

A. TABEL DISTRIBUSI WILAYAH KEJADIAN BENCANA (20 AUGUST 2026)

Evaluasi distribusi spasial dan pemetaan beban bencana pada tanggal 20 August 2026 menunjukkan pemusatan kejadian di wilayah koridor Kalimantan dengan variasi dampak sosial serta potensi krisis lingkungan sebagai berikut:

NO.	PROVINSI TERDAMPAK	TOTAL KEJADIAN	TOTAL KORBAN & PENGUNGSI	KABUPATEN / KOTA TERDAMPAK
1	KALIMANTAN TIMUR	1 Kejadian	44 Terdampak	KOTA BALIKPAPAN
2	KALIMANTAN TENGAH	2 Kejadian	0 Korban Dilaporkan	BARITO SELATAN, KAPUAS

B. STATUS & KESIAPSIAGAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Penilaian ketahanan dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di dalam radius siaga 25 km dari titik lokasi bencana menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan berada dalam kondisi utuh dan beroperasi penuh tanpa ada kerusakan fisik.

RUMAH SAKIT SIAGA 19 RADIUS 25 KM BENCANA	PUSKESMAS SIAGA 49 RADIUS 25 KM BENCANA	KLINIK & PUSTU SIAGA 118 RADIUS 25 KM BENCANA	FASKES RUSAK (B/S/R) 0/0/0 NIHIL KERUSAKAN
--	--	--	---

Catatan Komando Faskes: Seluruh 19 RS Siaga, 49 Puskesmas Siaga, dan 118 Klinik/Pustu Siaga diinstruksikan untuk mempertahankan kesiapan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam serta memperkuat ketersediaan obat-obatan respirasi dan oksigen medis.

A. TREN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI & DAMPAK KEBENCANAAN (14 HARI)

Sintesis data tren 14 hari terakhir dan evaluasi indikator surveilans kesehatan masyarakat memberikan gambaran analisis sebagai berikut:



B. PROTOKOL TAKTIS TIM MEDIS DARURAT (EMERGENCY MEDICAL TEAM)

“ SINTESIS ANALISIS KECERDASAN BUATAN (EOC AI ENGINE — GEMINI 2.5 FLASH):

Protokol penugasan taktis di bawah ini disusun secara otomatis oleh model AI Gemini 2.5 berdasarkan integrasi indikator morbiditas korban, data kejadian harian, ketersediaan faskes siaga, dan pemodelan risiko kebencanaan untuk percepatan komando penanganan krisis kesehatan. ”

- Aktivasi & Kesiapsiagaan EMT Tipe 1 (Fase Preventif / Siaga)**
Menyiagakan Tim Medis Darurat (EMT Tipe 1 Mobile) di Dinkes Kab. Barito Selatan, Kapuas, dan Kota Balikpapan untuk pelayanan kesehatan penjangkauan (outreach) dan deteksi dini krisis.
- Kesiagaan Rumah Sakit Rujukan Regional & SPGDT**
Memastikan keterhubungan SPGDT 119 dan kesiapan triase bencana di 19 RS Rujukan Regional penyangga guna mengantisipasi rujukan kasus gawat darurat respirasi/trauma.
- Penguatan Surveilans SKDR/EWARS Berkelanjutan**
Meningkatkan frekuensi pelaporan SKDR harian di seluruh Puskesmas terdampak untuk memantau tren penyakit ISPA, Diare, dan penyakit kulit pascabencana secara real-time.

Dokumen Laporan Infografis Eksekutif EOC Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI ini diterbitkan secara resmi sebagai basis pengambilan keputusan strategis pimpinan dan koordinasi inter-sektoral nasional.

DISAHKAN
SECARA DIGITAL
EOC KEMENKES RI
21 August 2026

Kepala Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI